

КОМПЛЕКТ СПИКЕРА · 26.08.2026

# Карточка Q&A · 22 вопроса

*Короткий ответ · развёрнутый · источник · граница уверенности*

**Документ:** рабочий файл модератора сессии «Организация питания: опыт реализации проектов», 26.08.2026, 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». **Версия:** 22.08.2026. **Состав:** 22 вопроса в 7 категориях. **Формат каждого ответа:** - **Короткий** (20–30 сек) — для устного ответа в зале. - **Развёрнутый** — для аргументации в зале или после сессии. - **Источник** — что подложить, если попросят. - **Граница уверенности** — что можно утверждать, что — нет. - **Избегать** — формулировка, которой нельзя отвечать.

## Категория 1. Юридические (5 вопросов)

### Q1. ЗАКОН ПРЯМО ТРЕБУЕТ ВАРИАТИВНОЕ МЕНЮ В ПНИ?

**Короткий (20 сек):** «Нет. Закон не требует и не запрещает. 442-ФЗ даёт право на уважительное отношение, ИППСУ и пищевые предпочтения, где уместно. 3185-1 даёт право на гуманное отношение. СанПиН требует не менее 3 приёмов и диетическое по показаниям. Вариативность — организационная модель внутри этих рамок».

**Развёрнутый:** Федеральное право не обязывает предоставлять выбор каждого блюда. Ст. 9 442-ФЗ — право на «уважительное и гуманное отношение». Ст. 16 — ИППСУ «исходя из потребности гражданина». Ст. 32 ч. 4 — предельная плата 75 % среднедушевого дохода. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 — «уважительное и гуманное отношение, исключаящее унижение человеческого достоинства». Ст. 43 — права лиц, проживающих в стационарных организациях для лиц, страдающих психическими расстройствами. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 7.1.11 (до 31.08.2026) и СанПиН 2.3/2.4.4282-26 п. 56 подп. 11 (с 01.09.2026) — не менее 3 приёмов + диетическое по показаниям.

**Источник:** 442-ФЗ, 3185-1, СанПиН 3590-20 / 4282-26.

**Граница уверенности:** высокая — это прямая норма.

**Избегать:** «Закон не запрещает» (как единственный аргумент). Лучше: «запрета нет, но и прямой обязанности нет; речь о выборе модели».

### Q2. УЧРЕДИТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН — ЧТО ДЕЛАТЬ?

**Короткий (20 сек):** «Уведомить, не запрашивать разрешение. Федеральный закон не запрещает. Региональные нормы — рекомендательные. Письмо-уведомление с обоснованием + согласование сроков пилота. Отказ учредителя — повод для протокола разногласий, не для отказа от пилота».

**Развёрнутый:** Письмо-уведомление (1 страница) с обоснованием (Новосибирская и Иркутская области, СПб; ссылки на СанПиН и 442-ФЗ; сроки пилота; точка пилота — одно отделение) + просьба о согласовании. **Не запрашивать разрешения** — уведомлять. Региональные нормы питания (например, ПП Москвы № 1068-ПП, ПП Красноярского края № 607-п) устанавливают граммовки и калорийность, но не запрещают вариативность в пределах раскладки. Если учредитель категорически против — это сигнал для эскалации, а не для отказа.

**Источник:** S030 (Комитет по социполитике СПб, 22.07.2025), S031 (письмо Комитета 19.08.2026 о контроле за поставщиками), S015–S018 (практики учреждений).

**Граница уверенности:** высокая на уровне федерального права; средняя — на уровне регионального (зависит от региона).

**Избегать:** «Учредитель запретил — поэтому не делаем». Это ошибка — учредитель не имеет права запретить то, что не запрещено федеральным законом.

### Q3. ПРОКУРАТУРА СПРАШИВАЕТ ПРО ВАРИАТИВНОЕ МЕНЮ — ЧТО ОТВЕЧАТЬ?

**Короткий (30 сек):** «Не ссылкой на “запрета нет”, а комплектом документов: положение об организации питания, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Этот комплект закрывает тему. Формула “запрета нет” — слабый аргумент, нужна бумага, которая разрешает у вас».

**Развёрнутый:** Прокуратура проверяет не “можно ли вариативно”, а “есть ли документы”. Дела по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарных правил) — про качество и достаточность, не про «два вторых» (S012: Кашин СРЦ 2022, Зеленогорск 2021, представление 19.03.2024). Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4 (S022) — перекалфикация 6.6 → 6.7 КоАП. **Минимальный комплект для прокурора:** положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем, приказ о рабочей группе, письмо-уведомление учредителю с ответом. 8 документов. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки.

**Источник:** S012 (прокуратура, дела 6.6 КоАП), S022 (ВС РФ 2019), S031 (письмо Комитета 19.08.2026).

**Граница уверенности:** высокая на уровне дел 6.6 КоАП; средняя — на уровне «как ответить конкретному прокурору» (зависит от региона).

**Избегать:** «Закон не запрещает». Это **самая частая ошибка** директоров в диалоге с прокуратурой.

### Q4. КТО НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ЖИТЕЛЬ С ДИСФАГИЕЙ ПОДАВИТСЯ?

**Короткий (30 сек):** «Ответственность за систему контроля, не за каждое событие. Суды проверяют: был ли список риска, была ли таблица врача “лекарство × еда”, обучался ли персонал, задокументирован ли инцидент. Если всё это есть — обвинение в халатности не проходит».

**Развёрнутый:** Ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 6.6 КоАП. **Ответственность наступает не за каждое событие, а за неработающий контроль.** Письмо учредителю о дефиците ресурсов не индульгенция, но доказательство своевременного реагирования. **Граница 4.0 исходного доклада (что кухня не назначает) — главный защитный механизм директора:** текстуру назначает врач, кухня исполняет.

**Источник:** S012 (практика прокуратуры), S032/S033 (приказы Минздрава 330н/395н — лечебное питание).

**Граница уверенности:** средняя (юридическая практика различается по регионам).

**Избегать:** «Кухня виновата». Это ошибка — кухня не назначает, врач назначает.

### Q5. УЧРЕЖДЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ОПЕКУН ЖИТЕЛЯ — ЭТО КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ?

**Короткий (30 сек):** «Да, и это не юридический нонсенс, а управленческая задача каждого ДСО. 99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения (117 000 чел., проект “Если быть точным” 2024). Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 говорит о праве на гуманное отношение — этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают».

**Развёрнутый:** Прямого запрета в федеральном законе нет, но ст. 41 ГК РФ (конфликт интересов опекуна) и ст. 23 48-ФЗ обязывают опекуна действовать в интересах подопечного. 99 % опеки в одном учреждении — это не уникальный риск Серафимовского, это **общероссийская норма**.

Решение — задокументированный процесс выражения воли (пищевая карта, журнал заказа, совет жителей), а не «особое юридическое лицо».

**Источник:** S004 (M-ebt, проект «Если быть точным», tochno.st), ст. 41 ГК РФ, ст. 23 48-ФЗ.

**Граница уверенности:** высокая (прямая статистика); средняя (юридическая оценка конфликта интересов).

**Избегать:** «У нас нет конфликта интересов» — это ошибка. Конфликт есть, его надо признать и управлять.

## Категория 2. Медицинские (5 вопросов)

### Q6. ДИСФАГИЯ — ЭТО СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ?

**Короткий (20 сек):** «Мы не знаем. Систематический обзор Miarons Font, Rofes Salsench 2017 даёт 21,9–69,5 % в изученных клинических группах на антипсихотиках. Это не российские ДСО, и цифра для нашего учреждения может быть любой. Пилот за 90 дней даст собственные данные — список риска, скрининг GUSS (адаптированный), % подтверждённой дисфагии в нашем отделении».

**Развёрнутый:** Диапазон 21,9–69,5 % в обзоре 18 исследований (Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29(12):1332-9). **Источник:** Font L. et al. **Популяции — пациенты, принимающие антипсихотики, не российские ДСО; перенос не доказан.** Валидирующее исследование PMC10527768 (2023) — 26,2 % у AP-пользователей. **В российских ДСО распространённость не измерена.** Это первая задача врача в ФАЗЕ 1 пилота: сформировать список риска по 6 признакам (раздел 10.3 исходного доклада).

**Источник:** M-dysph\_prev, M-dysph\_rev.

**Граница уверенности:** высокая на уровне обзора; низкая — на уровне переноса.

**Избегать:** «У нас каждый третий-четвёртый» — без собственного замера.

### Q7. IDDSI ВНЕДРЯТЬ — ИЛИ ЭТО ЛИШНЕЕ?

**Короткий (20 сек):** «IDDSI — это язык, на котором кухня, отделение и врач говорят о текстуре без потери смысла. Язык без назначения — пустая форма; назначение без языка — риск неисполнения. Внедрение начинается с обучения смены и одного постера на кухне. IDDSI не лечит — но без него “протёртое” у каждой смены разное».

**Развёрнутый:** Cichero J.A.Y. et al. Dysphagia 2017;32(2):293-314 — IDDSI framework, 8 уровней (0–7). Wu X.S. et al. Dysphagia 2022;37(5):1314-1325 — в 5 учреждениях aged care (общее long-term care, **не психиатрия**) соответствие текстур выросло с 44 до 90 %; эффект сохранялся 6 мес. **Прямой перенос на психиатрический контингент не доказан**, правомерно говорить о принципиальной воспроизводимости механизма (обучение → рост соответствия). IDDSI — терминология, не протокол. Текстуру назначает врач.

**Источник:** M-iddsi2017, M-iddsi\_wu.

**Граница уверенности:** высокая на IDDSI как стандарт; средняя — на эффект в психиатрии.

**Избегать:** «IDDSI — это лечебный протокол». Это ошибка.

### Q8. КЛОЗАПИН И КОФЕ — ЧТО ДЕЛАТЬ?

**Короткий (20 сек):** «Кухня не отменяет кофе. Врач оценивает риск и документирует решение. В таблице “лекарство × еда” на посту — строка про клозапин и кофеин. Hägg et al. 2000 (12 здоровых

добровольцев, однократная доза) показал +19 % AUC клозапина при 400–1000 мг кофеина. У конкретного пациента эффект может быть другим. Решение — за врачом, не за поваром».

**Развёрнутый:** Hägg S. et al. Br J Clin Pharmacol 2000;49(1):59-63. 12 здоровых некурящих мужчин-добровольцев, однократная доза клозапина 12,5 мг, кофеин 400–1000 мг/день. **Не пациенты с шизофренией; однократная доза, не steady-state.** Клинические случаи тяжёлой токсичности описаны (Yartsev P. et al. 2021, PMC8043221). Кухня **не** отменяет кофе; **врач** оценивает риск и документирует. Если житель на клозапине стабильно пьёт кофе — это норма; если резко увеличивает — повод для оценки.

**Источник:** M-cloz\_hagg, M-cloz\_case, M-cloz\_wd.

**Граница уверенности:** высокая (механизм CYP1A2); средняя (конкретные цифры у конкретного пациента).

**Избегать:** «Кофе при клозапине опасен, надо запретить». Это ошибка.

### Q9. 76,3 % ПРИБАВКА ВЕСА НА КЛОЗАПИНЕ — ЭТО ПРО ВСЕХ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ?

**Короткий (20 сек):** «Нет. 76,3 % — это Campforts et al. 2023 (BJPsych Open 9(1):e18), мета-анализ 202 исследований, **клозапин >38 недель**. Это доля пациентов с прибавкой  $\geq 7$  %. Не все пациенты, не короткий курс, не молодые/пожилые отдельно. У нас доля будет другой — посчитайте свою за 6 месяцев».

**Развёрнутый:** 76,3 % — Campforts B. et al. BJPsych Open 2023;9(1):e18, клозапин >38 нед,  $\geq 7$  % прибавка веса. **Не путать** с Pillinger T. et al. Lancet Psychiatry 2020;7(1):64-77, где диапазон по 18 антипсихотикам за медиану 6 нед: -0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг (клозапин). **Это разные исследования, разная методология, разные цифры.** Оланзапин по Campforts — 36,9 %; рисперидон 16–38 нед — 23,0 %.

**Источник:** M-crwg, M-pillinger.

**Граница уверенности:** высокая на уровне обзоров; низкая — на уровне переноса на конкретное учреждение.

**Избегать:** «У нас каждый второй на клозапине». Без собственного замера.

### Q10. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ НА ЗАГУЩЁННЫХ ЖИДКОСТЯХ — КАК МОНИТОРИТЬ?

**Короткий (20 сек):** «Тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима. Объём выпитого за сутки (стакан как единица учёта) — на панели 5 чисел контингента. Steele SJ et al. Breathe 2021: убедительных данных о снижении респираторных осложнений при загущении нет, а нагрузка лечения есть. Решение о текстуре напитка — врача, с пересмотром, не навсегда».

**Развёрнутый:** Steele S.J., Ennis S.L., Dobler C.C. Breathe (Sheff) 2021;17(1):210003. doi: 10.1183/20734735.0003-2021. «There is no conclusive evidence to support thickened fluids to prevent dysphagia-related clinical complications, including aspiration pneumonia. Thickened fluids reduce HRQoL in patients with dysphagia.» Cochrane 2022 (CD012416.pub3) подтверждает, что профессиональный уход за полостью рта может снижать пневмонию-ассоциированную смертность (RR 0,43, 95 % ДИ 0,25–0,76), но с низкой определённостью. **«Загустить и забыть» — худшая стратегия.**

**Источник:** M-dehydr\_steele, M-dehydr\_li, M-oral\_yoneyama, M-oral\_muller, Cochrane CD012416.pub3.

**Граница уверенности:** высокая (механизмы); средняя (конкретные цифры в популяции).

**Избегать:** «Загущённые напитки решают проблему аспирации». Это не доказано.

## Категория 3. Финансовые (3 вопроса)

### Q11. ВАРИАТИВНОЕ ПИТАНИЕ ДОРОЖЕ ОБЫЧНОГО — ГДЕ ДЕНЬГИ?

**Короткий (20 сек):** «Не дороже, если правильно. Семидневный замер отходов до pilota даст базовую цифру. В Успенском ПНИ и Болотнинском ПНИ (Новосибирская обл.) вариатив ввели без повышения сметы. Если после 90 дней выходит экономия — это побочный эффект, не цель. Цель — доступность выбора и безопасность».

**Развёрнутый:** В 4 публичных кейсах (Серафимовский, Успенский, Болотнинский, Иркутская обл.) вариатив введён **без повышения платы для жителей**: разница в стоимости компенсировалась перераспределением продуктовой корзины, отказом от «несъедаемых» позиций и снижением отходов. **Но:** «национальной доли отходов нет» — её даёт семидневный замер в пилоте. Формула «вариативность почти бесплатна» в исходной версии доклада **снята** (анти-слоп контроль v1.5). Честная рамка: стоимость варьирует, замер обязателен.

**Источник:** S015, S016, S017, S018, S030.

**Граница уверенности:** средняя (конкретные суммы зависят от учреждения).

**Избегать:** «Вариативность бесплатна» или «Вариативность дорога на 30 %». Оба — без замера.

### Q12. СЫРЬЕВАЯ СТРОКА — ЗАЧЕМ ЕЁ СЧИТАТЬ?

**Короткий (20 сек):** «Это первая цифра для всех финансовых аргументов. Без неё — “мы не знаем, сколько стоит еда”. Считается за 1 час: расходы на продукты за последний полный месяц ÷ жители ÷ дни. Если за 5 минут никто не называет своё число — это первая находка аудита, важнее самого числа».

**Развёрнутый:** Методика в исходном докладе 4.5, 29.3 и приложении 25. Региональные тарифы (Алтайский край — 422 руб./чел./день по решению Управления № 84 от 27.06.2025; S021 — региональные нормы) дают ориентир, но **конкретное учреждение считает свою**. Сравнение с региональной нормой — повод для разговора с учредителем, не для автоматического перерасхода.

**Источник:** S002 (приказ Минтруда 520н), S020, S021, S029.

**Граница уверенности:** высокая (формула простая).

**Избегать:** «У нас всё в порядке с деньгами». Без числа — это не ответ.

### Q13. АУТСОРСИНГ ПИТАНИЯ — КОНФЛИКТ С ВАРИАТИВНОСТЬЮ?

**Короткий (20 сек):** «Нет, если в контракте строка “выбор”. Серафимовский — 223-ФЗ (автономное учреждение); Тесовый берег — 44-ФЗ (бюджетное). В обоих случаях вариативность — это условие спецификации. Без строки в контракте — подрядчик готовит то, что в раскладке, и точка».

**Развёрнутый:** Контракт на аутсорсинг питания — это **место, где вариативность становится обязательством подрядчика**. Если в ТЗ нет строки «предусмотреть выбор из N вариантов по приёмам», подрядчик готовит строго по циклограмме. **Два типичных сценария:** (а) внутренняя кухня — гибче, но нагрузка на штат; (б) аутсорсинг — дешевле, но жёстче в спецификации. Выбор модели — за учреждением, **оба работают** при правильной формулировке контракта.

**Источник:** S034 (извещение Тесового берега 0372200070825000244 от 24.11.2025), S023 (44-ФЗ), S035 (локальный приказ Серафимовского).

**Граница уверенности:** высокая (закупочные процедуры).

**Избегать:** «Аутсорсинг несовместим с вариативностью». Неправда.



## Категория 4. Управленческие (3 вопроса)

### Q14. ПИЛОТ ЗА 90 ДНЕЙ РЕАЛИСТИЧЕН?

**Короткий (20 сек):** «Да, на одном отделении без новой сметы. 30 дней замер → 30 дней документы и обучение → 30 дней пилот. 5 обязательных групп показателей. 6 стоп-критериев. Если получится у “сложного” отделения (помощь, неговорящие) — получится у всех».

**Развёрнутый:** См. 09\_инструменты/паспорт\_пилота\_90\_дней.md. Три фазы. 16 документов в комплекте. 6 стоп-критериев (рост пневмоний  $\geq 30\%$ , падение со смертельным исходом, жалоба в прокуратуру, приказ учредителя, отзыв согласия, отсутствие врача). **Успех — не “% выбравших”, а доступность выбора + исполнение заказа + отсутствие событий риска.**

**Источник:** S015, S016, S030 (практики), раздел 35 исходного доклада.

**Граница уверенности:** высокая (методика отработана).

**Избегать:** «Нужно минимум полгода». Без замера — нет.

### Q15. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПИЛОТ НЕ ПОКАЗАЛ ЭФФЕКТА?

**Короткий (20 сек):** «Это тоже результат. “Не получилось” говорит, что в вашем учреждении нужно менять — медицинскую рамку, пары эквивалентов, обучение смены или модель. Решение принимается по 5 группам показателей: 4 из 5 в норме — масштабируем; 3 из 5 — корректируем; 2 и меньше — останавливаем и анализируем».

**Развёрнутый:** Стоп-критерии и критерии успеха — в паспорте пилота. **Главное правило:** пилот — **измеримая гипотеза**, а не обещание успеха. Плохой результат — это вход в следующий цикл, а не провал.

**Источник:** методология исходного доклада (раздел 35), паспорт пилота v2.

**Граница уверенности:** высокая (методология).

**Избегать:** «Если не получилось — закрываем программу». Это ошибка.

### Q16. ПЕРСОНАЛ — КАК ОБУЧАТЬ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ?

**Короткий (20 сек):** «Три занятия по 40 минут + IDDSI-тест повара + инструктаж смены. Минимум 8 часов на сотрудника за 90 дней. График — в журнале обучения. Без обучения пилот не запускать — это стоп-критерий №7 (обучение < 8 часов на сотрудника)».

**Развёрнутый:** Программа обучения: (1) 6 признаков дисфагии (раздел 10.3); (2) правило «3 отказа → врач»; (3) IDDSI-тест (вилка, ложка, наклон) для повара; (4) техника помощи (поза, темп); (5) документы (журнал заказа, журнал отказов). **Главный барьер внедрения IDDSI — не техника, а осведомлённость персонала** (Wu 2022). Практика показывает: обучение — главный инвестиционный ресурс.

**Источник:** M-iddsi\_wu (Wu 2022), M-pm\_rev, M-oral\_yoneyama.

**Граница уверенности:** высокая.

**Избегать:** «Обучим потом, по ходу дела». Без обучения пилот не запускать.

## Категория 5. Этические (3 вопроса)

### Q17. КАК БАЛАНСИРОВАТЬ ВЫБОР И БЕЗОПАСНОСТЬ?

**Короткий (20 сек):** «Безопасность имеет приоритет. Выбор — внутри медицинской рамки. Граница 4.0 (что кухня не назначает): текстуру, лечебный стол, сдвиг времени еды у инсулинозависимых, длительный отказ — только врач. Внутри этой рамки — выбор. Вне рамки — врач решает, документирует, оформляет информированное решение».

**Развёрнутый:** Эта формула в исходном докладе сформулирована дословно: «кухня исполняет назначение, не ставит диагноз». Внутри медицинской рамки человек выбирает: что из двух вариантов, когда выйти в зал, какую порцию. Вне рамки — врач принимает решение и документирует. Если житель с дисфагией настаивает на обычной пище — это оформляется «осознанным риском» с врачом, а не самостоятельностью сиделки.

**Источник:** 3185-1 ст. 5 ч. 2, 28, 36, 39; 442-ФЗ ст. 9; раздел 4.0 и 10.5 исходного доклада.

**Граница уверенности:** высокая.

**Избегать:** «Безопасность важнее выбора». Да, но это не отменяет выбора внутри безопасной рамки.

### Q18. НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ВЫБОР — ФИКЦИЯ?

**Короткий (20 сек):** «Нет. Международное право (КПИ, Замечание общего порядка № 1 к ст. 12) требует поддержанного, а не замещающего принятия решений. Показ двух порций, наблюдение за реакцией, пищевая биография — это способы выражения воли без слов. У 11 % постельных и значительной доли неговорящих жителей ПНИ это единственный канал воли. Закрывать его — значит превратить их в объект заботы».

**Развёрнутый:** Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014) — «замещающее принятие решений несовместимо со ст. 12; поддерживаемое принятие — обязательство государства». Россия ратифицировала КПИ (ФЗ от 03.05.2012 № 46-ФЗ).

**Немецкий стандарт (DGE-QST) требует собирать «биографию питания» при поступлении** — потому что эти сведения позже могут стать единственным доступом к воле человека. В исходном докладе раздел 15 — отдельная глава про невербальный выбор. Форма пищевой биографии — приложение 3.

**Источник:** ст. 12 КПИ, Замечание общего порядка № 1 (2014), DGE-QST (Германия), раздел 15 исходного доклада.

**Граница уверенности:** высокая.

**Избегать:** «Они не могут выбирать». Это подменяющее принятие решений.

### Q19. СОВЕТ ЖИТЕЛЕЙ — ОБЯЗАТЕЛЕН?

**Короткий (20 сек):** «По закону — нет. По практике — полезен. ДДСОЛ (Московская область, S019) — 14-дневное вариативное меню с советом по питанию, замены по желанию жителей с врачом. Успенский ПНИ (S016) — вариатив во всех отделениях. Совет жителей — не самоцель, а канал обратной связи и легитимации. Если у вас его нет — это не препятствие для пилота; если есть — подключите на ФАЗЕ 2 при обсуждении пар эквивалентов».

**Развёрнутый:** 442-ФЗ не устанавливает обязательности совета жителей. Ст. 19 «права поставщиков социальных услуг» — без прямого указания на совет. Но раздел 34 исходного доклада — отдельная глава про совет жителей. ДДСОЛ ([ddsol.ru/about/pitanie/](http://ddsol.ru/about/pitanie/)) — пример учреждения, где совет работает.

**Совет полезен на этапе формирования пар эквивалентов** (ФАЗА 2 пилота), не как контролёр.

**Источник:** S019 (ДДСОЛ), S016 (Успенский), раздел 34 исходного доклада.

**Граница уверенности:** высокая.

**Избегать:** «Совет обязателен, иначе не запустим». Неправда.

## Категория 6. Закупочные (2 вопроса)

### Q20. 44-ФЗ И 223-ФЗ — В ЧЁМ РАЗНИЦА ДЛЯ НАШЕГО ПИЛОТА?

**Короткий (20 сек):** «44-ФЗ — для бюджетных учреждений (Тесовый берег). 223-ФЗ — для автономных (Серафимовский) и госкорпораций. Для пилота разница в процедуре: 44-ФЗ требует конкурентных процедур, 223-ФЗ — положение о закупках учреждения. Вариативность в обоих случаях возможна, но оформляется по-разному».

**Развёрнутый:** СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» — **автономное** учреждение (тип «А»), закупки по 223-ФЗ. СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“» — **бюджетное** (тип «Б»), закупки по 44-ФЗ. **Извещение Тесового берега 0372200070825000244** от 24.11.2025 (S034) — открытый конкурс в электронной форме «Поставка продуктов питания», опубликовано на tenderguru.ru. **Локальный приказ № 124 Серафимовского (S035)** — заказное питание закреплено в правилах внутреннего распорядка. **Обе схемы работают** при правильной формулировке спецификации.

**Источник:** S023 (44-ФЗ), S034 (извещение Тесового берега), S035 (приказ Серафимовского), 223-ФЗ.

**Граница уверенности:** высокая.

**Избегать:** «44-ФЗ не позволяет вариативность». Неправда.

### Q21. КОНТРАКТ С ПОДРЯДЧИКОМ — КАК ВКЛЮЧИТЬ ВАРИАТИВНОСТЬ?

**Короткий (20 сек):** «В техническом задании: строка “предусмотреть выбор из 2 вариантов по приёмам (завтрак, обед) для 100 % жителей пилотного отделения; варианты эквивалентны по граммовкам и калорийности; замена по таблице пар”. В проекте контракта — ответственность подрядчика за неисполнение (штраф, расторжение, РНП)».

**Развёрнутый:** Письмо Комитета по соцполитике СПб (S031, 19.08.2026) — контроль за поставщиками по ст. 34, 94, 95 44-ФЗ: ежедневный мониторинг, акты, претензии, одностороннее расторжение, РНП. **Включение вариативности в ТЗ — не «льгота» подрядчику, а требование заказчика.** Подрядчик, не готовый обеспечить выбор, не соответствует ТЗ.

**Источник:** S031, S034, 44-ФЗ ст. 34, 94, 95.

**Граница уверенности:** высокая.

**Избегать:** «Подрядчик сам решает, как готовить». Нет — решает заказчик в ТЗ.

## Категория 7. Санитарные (1 вопрос)

### Q22. САНПИН 4282-26 — ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАС?

**Короткий (20 сек):** «С 01.09.2026 вступает в силу новая редакция (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854). Действует до 01.09.2032. Старая редакция 3590-20 утрачивает силу. Главное для учреждений соцобслуживания — п. 56 подп. 11 (не менее 3 приёмов + диетическое по показаниям). Формулировка сохранена в обеих редакциях, но **через 6 дней после семинара нужно проверить, нет ли новых требований к документации**».

**Развёрнутый:** Пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18 ([publication.pravo.gov.ru/document/0001202606020084](https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202606020084)). **На дату 22.08.2026 — «Документ не вступил в силу»** ([consultant.ru](https://consultant.ru)). С 01.09.2026 утрачивает силу пост. от 27.10.2020 № 32 (СанПиН 3590-20). **Практический эффект для**



**ПНИ/ДСО:** уточнить в новой редакции требования к журналам бракеража, отходов, пищевых карт; требования к температуре подачи; требования к лечебному питанию (п. 56). Контроль — Роспотребнадзор.

**Источник:** S003, consultant.ru, publication.pravo.gov.ru.

**Граница уверенности:** высокая (дата и реквизиты).

**Избегать:** «СанПиН не меняется». Меняется — через 6 дней после семинара.

## Итоговая сводка

| Категория      | Кол-во    | Самый опасный вопрос                                    |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Юридические    | 5         | Q3 (прокуратура) — без комплекта документов             |
| Медицинские    | 5         | Q8 (клозапин + кофе) — кухня не отменяет                |
| Финансовые     | 3         | Q11 (дороже ли) — без замера не знаем                   |
| Управленческие | 3         | Q15 (что если не получилось) — это результат, не провал |
| Этические      | 3         | Q18 (невербальный выбор) — это право, а не фикция       |
| Закупочные     | 2         | Q21 (как включить в ТЗ) — это требование заказчика      |
| Санитарные     | 1         | Q22 (СанПиН 4282-26) — меняется через 6 дней            |
| <b>Всего</b>   | <b>22</b> | —                                                       |

**Дата:** 22.08.2026. **Применяется:** модератором сессии 26.08.2026. **Источники:** Miarons Font 2017, Correll 2022, Pillinger 2020, Campforts 2023, Hägg 2000, Wu 2022, Yoneyama 2002, Sjogren 2008, Cichero 2017, Steele 2021, СанПиН 4282-26, 442-ФЗ, 3185-1, реестры S001–S035. **Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки.**